EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69643
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-24 11:07:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ROUSSETT ELIZABETH PITRE INFANTE			RUN	: 28.114.964-4
F.Nac	: 21-12-2001	Edad	: 21 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: ÑUBLE 328			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-08-17	Fecha Egreso	: 2023-08-24 11:07:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente sin antecedentes patologicos de importancia que ingresa por cuadro de varios dias de evolucion de dolor abdominal asociado a disuria y fiebre, a su ingreso a servicio de urgencia hipotensa, taquicardica, subfebril, se reciben laboratorios en los que destaca cuenta blanca en 21.800, PCR 418, uroanalisis con orina inflamatoria con leucocitos de >100 x campo, en vista de cuadro se decide ingreso a la unidad para manejo antibiotico.
Glicemia : 106 mg/dl, Creatinina : 0,70 mg/dl, Fosfatasa Alcalina : 101 U/L, Bilirrubina Indirecta : 0,65 mg/dL, Bilirrubina Directa : 0,35 * mg/dL, Bilirrubina Total : 1,00 mg/dL, ASAT/GOT : 19 U/L, ALAT/GPT : 19 U/L, Gama GT : 43 U/L, Clearence Calculado(MDRD) : 105,63 ml/min/1,73, Lactato : 1,4 mmol/L, Proteina C Reactiva : 418,7 * mg/L, Uremia : 21 mg/dl, Sodio (Na) : 136,00 mmol/L, Potasio (K) : 3,50 mmol/L, Cloro (Cl) : 98,00 mmol/L, Hemoglobina : 11,8 g/dl, Hematocrito : 35,2%, Recuento de leucocitos : 21,80 * mil/ul, Recuento Hematies : 3,77 * Mill/ul, Plaquetas : 305 mil/ul, INR : 1,32, Tiempo de Protrombina % : 66 *%, Tiempo de Protrombina seg : 16,7 seg, TTPA (seg) : 27.
TAC 17.8.2023 con hallazgosc ompatibles con pielonefritis aguda izquierda
Se hospitaliza en UTI con diagnostico de pielonefritis aguda izquierda.
COn regular respuesta a tratamiento antibiotico , aumento de parametros inflamatorios y fiebre en las primeras 48 horas.
Se decide toma de TAC abdomen y Pelvis CC para descarte de complicaciones.
TAC 20.8.2023 Absceso renal izquierdo 2.5cm x 1.7 cm
Se escala tratamiento antibiotico a TAzonam , con buena respuessta clinica y laboratorio con descenso de parametros inflamatorios rapidamente y sin nuevas alzas termicas.
Urocultivo 17.8 Negativo
Se decide cambio a ertapenem para manejo por hospitalización domiciliaria, actualmente paciente asintomatica, con parametros inflamatorios a la baja.

PLAN DE MANEJO:

Manejo por Hodom

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Hidratación abundante

3. Ertapenem 1 gr c dia por 5 días EV

EXÁMENES Y RESULTADOS

Crea 0,50, pcr 24,4, na 139, k 3,80, leu 8,40, hb 10,8.

Mariana Panique Pedraza
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO